

TEMA 3.5 • ENDOCRINOLOGÍA

Hipotiroidismo Subclínico

PERFIL EUNACOM 1.03.2.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hipotiroidismo Subclínico

Definición

- **TSH elevada + T4 libre NORMAL**
- Es **asintomático** por definición
- Si tiene síntomas → ya es **hipotiroidismo** clínico (aunque se llame "asintomático")

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir: "hipotiroidismo asintomático" ≠ "hipotiroidismo subclínico". El subclínico exige T4 libre **normal**.

Laboratorio

TABLA 3.5.1: TSH VS T4 LIBRE		
TSH	T4 LIBRE	DIAGNÓSTICO
↑	Normal (0,7–1,9 ng/dL)	Hipotiroidismo subclínico
↑	↓	Hipotiroidismo clínico (tratar)

Manejo General

- **Observar** + control anual con TSH + T4 libre
- Si ATPO positivos → control más frecuente (mayor riesgo de progresar)

Excepciones: tratar como hipotiroidismo ("Las D")

TABLA 3.5.2: INDICACIÓN VS DETALLE	
INDICACIÓN	DETALLE
TSH > 10	Tratar independiente de síntomas
Dislipidemia	↑ colesterol u otra
Demencia en adulto mayor	Empírico, para ver si revierte síntomas
Depresión	Con asterisco; evidencia débil
Embarazo	Tratar siempre → riesgo de afectar desarrollo neurológico fetal

Tratamiento si indicado: levotiroxina igual que hipotiroidismo clínico

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 45 años asintomática. Exámenes: TSH 7,5 mU/L, T4 libre 1,1 ng/dL, colesterol total 180 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hipotiroidismo Subclínico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hipotiroidismo subclínico = TSH elevada + T4 libre NORMAL. Es asintomático por definición de laboratorio.
- No confundir hipotiroidismo asintomático (T4 baja) con subclínico (T4 normal). Son conceptos distintos.
- Manejo habitual: observar y controlar con pruebas tiroideas al menos anualmente.
- Anti-TPO positivos = mayor riesgo de evolucionar a hipotiroidismo franco (Hashimoto). Control más frecuente.
- Excepciones para tratar (las D): TSH >10, Demencia, Dislipidemia, Depresión (discutible), y embarazo.
- En embarazo siempre se trata el hipotiroidismo subclínico por riesgo de daño neurológico fetal.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO)

PREGUNTA 1

Mujer de 45 años asintomática. Exámenes: TSH 7,5 mU/L, T4 libre 1,1 ng/dL, colesterol total 180 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Iniciar levotiroxina inmediatamente
- B) Observar y controlar con pruebas tiroideas periódicas
- C) Solicitar RMN de hipófisis
- D) Solicitar cintigrafía tiroidea
- E) Repetir exámenes en 24 horas

PREGUNTA 2

Mujer de 50 años asintomática con TSH 12 mU/L y T4 libre 0,9 ng/dL (normal). ¿Cuál es la conducta?

- A) Observar solamente
- B) Tratar con levotiroxina
- C) Solicitar anticuerpos anti-TPO antes de decidir
- D) Derivar a endocrinología sin tratamiento
- E) Iniciar yodo suplementario

RESUMEN: HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO

El hipotiroidismo subclínico es asintomático por definición y se diagnostica por laboratorio: TSH elevada con T4 libre normal (0,7-1,9 ng/dL). Es fundamental no confundir hipotiroidismo asintomático (T4 libre baja) con subclínico (T4 libre normal), ya que son conceptos distintos. El manejo habitual es observar, controlar cada cierto tiempo (al menos anualmente) con pruebas tiroideas, y hacer seguimiento más frecuente si los anticuerpos anti-TPO están positivos (mayor riesgo de evolucionar a hipotiroidismo). Si vienen con anti-TPO positivos, tiene riesgo de evolucionar a tiroiditis de Hashimoto franca. Las excepciones donde SÍ se trata (las D): TSH >10 (diezmo), demencia en adulto mayor (discutible), dislipidemia (especialmente hipercolesterolemia), depresión (evidencia débil), y embarazo (por riesgo de daño neurológico fetal). En estos casos se trata igual que un hipotiroidismo franco con levotiroxina.